CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche IV – E – 7
Version 3.0.0
Du 19/06/2026

CONDUITE À TENIR

Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ

Affections liées à la chaleur ou à l'effort

DÉFINITION

Élévation anormale (> 37,5 °C) et prolongée de la température corporelle plus ou moins accompagnée de différents signes non spécifiques provoquée par une exposition à la chaleur ou un effort prolongé.

La forme d'évolution la plus grave, qui engage le pronostic vital, est le coup de chaleur (ou hyperthermie maligne d'effort), qui associe une température corporelle supérieure à 40 °C et des troubles neurologiques et qui évolue vers une détresse vitale avec notamment des troubles circulatoires.

CAUSES

Les affections liées à la chaleur sont dues :

- à une exposition prolongée à des températures élevées (canicule, personne enfermée dans un espace surchauffé)
- à un effort important et prolongé
- à l'association des deux.

Plus la température ambiante est élevée, plus l'organisme a du mal à perdre de la chaleur, surtout si le milieu est chaud, humide et qu'un effort est produit.

Les personnes âgées, les nourrissons ou les personnes qui présentent des maladies chroniques y sont particulièrement sensibles.

La prise de certains traitements ou toxiques, notamment lors de rave party, peut aussi les favoriser.

Une température centrale de l'organisme qui s'élève est associée à une perte d'eau et de sels minéraux (déshydratation).

Les manifestations liées à la chaleur sont aggravées par la durée de l'exposition et les vêtements contraignants qui empêchent l'évaporation de la sueur.

CONSÉQUENCES

Cette exposition prolongée à la chaleur peut entraîner, si elle n'est pas interrompue rapidement, des troubles graves du fonctionnement de l'organisme lorsque le système de thermorégulation de l'organisme est dépassé ou cesse de fonctionner.

Cette exposition peut entraîner une déshydratation, des atteintes du foie, des reins et des fonctions neurologiques et circulatoires pouvant entraîner des séquelles graves ou le décès de la victime.

BILAN

Le bilan circonstanciel (Fiche III-B) retrouve une victime qui a été exposée à la chaleur, au soleil ou qui a fait un effort important et prolongé.

Au bilan d'urgence vitale (Fiche III-C), la victime peut présenter :

- des signes d'une détresse respiratoire :
  - fréquence respiratoire élevée,
  - oppression thoracique,
  - sensation d'étouffement.
- des signes d'une détresse circulatoire :
  - fréquence cardiaque élevée,
  - hypotension artérielle,
  - troubles du rythme cardiaque (pouls irrégulier), pouvant évoluer vers un arrêt cardiaque.
- des signes d'une détresse neurologique :
  - désorientation, confusion, délire,
  - prostration ou troubles du comportement (agressivité, agitation).
  - perte de connaissance.
  - Convulsions.
- des signes cutanéo-muqueux :
  - peau chaude, rouge, couverte ou non de sueurs,
  - hémorragies sous-cutanées puis extériorisées,
  - température corporelle anormalement élevée (supérieure à 37,5 °C).

Lors du bilan complémentaire (Fiche III-D), sdi la victime est consciente sans atteinte neurologique elle se plaint::

- d'une sensation de faiblesse musculaire et de fatigue générale ;
- de céphalées, des bourdonnements d'oreilles ou des vertiges ;
- des nausées ;
- de crampes musculaires ou une hypertonie musculaire (muscle tendu, dur).

Suivant les circonstances et l'importance des manifestations, on parle de :

- **crampes** liées à la chaleur si la victime présente seulement des crampes,
- **insolation (ou épuisement hyperthermique)**: la victime a une impression de chaleur, elle se plaint de céphalées, voire de vertiges, d'une fatigue intense. Elle a la peau rouge, une fréquence cardiaque élevée et une température qui reste inférieure ou égale à 40°C.
- **coup de chaleur** : la victime présente des nausées, des vomissements et des signes de déshydratation. La peau de la victime est rouge, sèche et brûlante au toucher. Des troubles neurologiques progressifs qui reflètent une atteinte cérébrale (encéphalopathie) apparaissent. La victime éprouve des difficultés à marcher (démarche instable), manifeste de la confusion,

des troubles visuels et comportementaux. L'apparition de convulsions ou une perte de connaissance indique une aggravation de son état. Si la température corporelle peut être mesurée de manière fiable, elle dépasse 40°C[1].

PRINCIPES DE L'ACTION

- Soustraire la victime à la cause.
- Refroidir la victime rapidement
- Réhydrater si cela est possible
- Demander un avis médical dans les cas d'épuisement hyperthermique et du coup de chaleur.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Matériel de premiers secours, lot A, B ou C.
- Moyens de refroidissement.

CONDUITE À TENIR

Dans tous les cas

- Réaliser un **refroidissement passif de la victime** (Fiche V-D-3).

La victime présente une détresse vitale

- Appliquer la conduite à tenir adaptée.

La victime ne présente pas de détresse vitale

- Installer la victime dans une position d'attente (Fiche V-D-3).
- Réhydrater la victime consciente avec de l'eau ou mieux un liquide contenant des glucides et des sels minéraux tels que jus de fruits ou boissons de l'effort sauf si elle présente des vomissements.

La victime présente des crampes

- Refroidir éventuellement avec l'application de poches de froid.
- Compléter l'action de secours par :
  - des étirements doux,

[1] Il est souvent difficile de mesurer de façon fiable la température en premiers secours, car cela nécessiterait un thermomètre rectal, peu adapté pour des raisons d'intimité, de culture et de formation. Les mesures tympaniques, buccales ou cutanées ne fournissent qu'une estimation imparfaite de la température réelle de la victime. Si la température ne peut pas être mesurée avec certitude mais que la victime présente les signes typiques d'un coup de chaleur, vous devez considérer qu'elle a une température corporelle supérieure à 40 °C et agir en conséquence

.

    - des massages musculaires.
- Indiquer à la victime de ne pas reprendre l'activité avant l'arrêt complet des signes.

La victime présente des signes d'insolation ou d'épuisement hyperthermique

- Réaliser un **refroidissement actif simple** (Fiche V-E-15) en utilisant les moyens disponibles.
- Poursuivre le bilan et le transmettre pour avis
- Surveiller la victime attentivement.

La victime présente les signes d'un coup de chaleur

- Réaliser un **refroidissement actif avancé** (Fiche V-E-15) de la victime en privilégiant les moyens sur place (Fiche V-E-15).
- Si cela n'est pas possible, réaliser un refroidissement actif simple (Fiche V-E-15).
- Poursuivre le bilan et surveiller attentivement :
    - l'évolution des signes de détresse vitale,
    - la température corporelle.
- Transmettre le bilan pour avis sans délai. Présenter tous les signes de gravité et appliquer les consignes reçues. Une prise en charge médicale urgente est nécessaire.

Le refroidissement actif doit se poursuivre jusqu'à la disparition des signes neurologiques ou jusqu'à ce que la température corporelle de la victime devienne inférieure à 39°C ou pendant 15 minutes si la température ne peut être mesurée.